Evidencia de Campo – MediAgenda

Datos de la entrevista

Campo	Información
Fecha	18 de octubre de 2026
Entrevistada	zaida Aparicio (Paciente)
Perfil	usuaria de clinicas
Medio de contacto	zaidaaparicio16@gmail.com/ +507 6332-8383 (Verificable)
Entrevistadora	Dana wing
Duración	25 minutos (audio / WhatsApp)

---

8 Preguntas realizadas y resumen de respuestas

1. ¿Cómo ha sido su experiencia personal al intentar agendar una cita médica recientemente?
Respuesta: La experiencia ha sido generalmente gratificante en cuanto al trato humano; el personal de recepción fue amable y solicitó todos los documentos necesarios de la persona a atender. Sin embargo, el proceso es netamente presencial o telefónico.

2. ¿Qué es lo que más le frustra o le toma más tiempo cuando necesita atender una urgencia o conseguir una cita con un especialista?
Respuesta: La gran frustración es la demora. Para una urgencia, el tiempo de espera en la sala es prolongado. Para conseguir una cita con un especialista, casi nunca hay disponibilidad inmediata; las citas se asignan para varias semanas después, lo que genera incertidumbre.

3. Si existiera una plataforma en línea para la clínica, ¿qué función le gustaría que tuviera para facilitarle la gestión de sus citas y las de su familia?
Respuesta: Que sea una página web muy fácil de entender, que permita gestionar todo sin depender de líneas telefónicas saturadas o de la disponibilidad de suficiente personal para atender llamadas.

4. Cuando la reciben en recepción por primera vez, ¿qué datos le piden? ¿Ha tenido problemas porque algún dato no quedó bien registrado?
Respuesta: Piden nombre, cédula, dirección, número de contacto, edad y si está asegurada. También

preguntan sobre alergias o enfermedades preexistentes. A veces, si el sistema es manual, sienten que la información no queda bien centralizada.

5. Si tiene un imprevisto y no puede asistir a su cita, ¿qué tan fácil o complicado es avisarle a la clínica y reprogramar?
Respuesta: Es un poco complicado. En ocasiones, los números telefónicos no contestan o son máquinas que no resuelven. En otros casos, exigen ir presencialmente hasta la clínica solo para cancelar la cita, lo que genera mucha demora y pérdida de tiempo.

6. ¿Cómo lleva usted el control de las citas que tiene programadas? ¿Ha tenido alguna situación de confusión?
Respuesta: Lo primero es confirmar la hora y la fecha verbalmente, y luego el paciente debe anotar manualmente en una agenda o calendario de papel el día y la hora de la cita para no olvidarlo.

7. Pensando en situaciones de atención médica, especialmente con niños o adultos mayores, ¿cree que el proceso actual pide toda la información necesaria para actuar rápido en caso de una complicación?
Respuesta: No siempre. En muchas ocasiones las clínicas no profundizan en preguntar si es alérgico a algún medicamento o comida, o si sufre de alguna enfermedad crónica específica, lo cual es vital en una emergencia.

8. ¿Alguna vez ha llegado a la clínica y le han dicho que el médico no está, o que es feriado y no hay atención? ¿Cómo resolvió esa situación?
Respuesta: Sí, ha sucedido. Le han dicho que el doctor no está y que debe esperar, regresar más tarde, atenderse con otro médico de turno o venir otro día. Es una situación muy incómoda, especialmente cuando uno ya se siente mal y tuvo que trasladarse hasta la clínica en vano.

---

3 Hallazgos que cambiaron el diseño del sistema

Hallazgo 1: La cancelación o reprogramación presencial/telefónica es ineficiente y frustrante.

Evidencia: La entrevistada destacó que a veces la obligan a ir físicamente a la clínica solo para cancelar, o las líneas no contestan (Pregunta 5). Además, lleva el control de sus citas en una agenda de papel (Pregunta 6).
Cambio en el diseño: Se implementó un módulo de autogestión en `principal-listado.html` y `perfil.html` que permite al paciente cancelar o reprogramar en línea. Para cumplir con la **Regla de Negocio** asignada, el sistema valida que el paciente haga este cambio con al menos **24 horas de anticipación**, mientras que el rol de Recepción puede hacerlo sin ese límite.

Hallazgo 2: Falta información crítica de salud y contacto para emergencias en el registro inicial.

Evidencia: La entrevistada señaló que a menudo no se registra si el paciente es alérgico a medicamentos o si sufre de alguna enfermedad, dato crucial para adultos mayores (Pregunta 7).
Cambio en el diseño: Se incorporó el **Cambio de Requerimiento** comunicado en clase (semana 5) agregando el campo obligatorio **"Teléfono de emergencia"** y secciones de antecedentes en el formulario de `registro.html`, garantizando que este dato esté disponible para el médico en `principal-detalle.html`.

Hallazgo 3: Trasladarse a la clínica y encontrar al médico ausente genera una mala experiencia.

Evidencia: La entrevistada relató la incomodidad de llegar a la clínica y que le digan que el doctor no está, obligándola a volver otro día (Pregunta 8).
Cambio en el diseño: El sistema MediAgenda bloquea automáticamente la disponibilidad de citas en días de **feriados nacionales** (Carnaval, 1 de julio) o ausencias médicas registradas, tal como se detalla en la propuesta y se visualiza en el calendario de `principal-formulario.html`, evitando traslados innecesarios.

Verificación

La entrevistada autorizó el uso de esta información con fines académicos y acepta ser contactada brevemente por el docente para confirmar la realización de la entrevista.